

Пациент: Мишин Александр Валентинович
Дата рождения: 13.12.1961 , 62 года Дата документа: 26.06.2024 09:38 Полис: 5047830836000228
ТИП ЭМПЗ: Выписной (переводной) эпикриз (Приказ 530н)

Выписной эпикриз РЭМД (Приказ 530н)

Наименование медицинской организации Поликлиника Московская область, р.п. Лотошино, ул. Спортивная д.9, к.1

ОГРН
1025007373863

Отделение: Терапевтическое отделение

Номер карты 1792/2024

Сведения о пациенте

ФИО Мишин Александр Валентинович
Дата рождения 13.12.1961 Пол Муж

Адрес пациента по прописке:
Московская обл, г Одинцово, ул Маршала Жукова, д 33, кв 35
Фактический адрес пациента:
Московская обл, г Одинцово, г Звенигород, ул Депутатская, д 3А

Тип стационара
1 - Стационар

Период нахождения в стационаре, дневном стационаре с

Дата и время поступления: 17.06.2024 19:45 Дата и время выписки 26.06.2024 09:36 Количество койко-дней 9

Исход госпитализации	Результат госпитализации	Форма оказания медицинской помощи
102 - Улучшение	101 - Выписан	2 - экстренная

Дополнительные сведения о пациенте и госпитализации

Полис пациента 5047830836000228
Сведения о направлении
17.06.2024 - 1792 - ГБУЗ Московской области Лотошинская больница

Жалобы

высокие сахара, боли в суставах кисти руки, головные боли,слабость, учащение сердцебиение.

Витальные параметры

Рост 175 Вес 75 ИМТ 24.49

Температура тела 36,6 Сатурация 97 ЧДД 18
Телосложение: гиперстеническое.
Описание кожного покрова тела -

Заключительный клинический диагноз

E10.7 - Инсулинзависимый сахарный диабет с множественными осложнениями.

Основное заболевание

Сахарный диабет 1 тип целевой уровень гликированного гемоглобина менее 7,5 %.

Осложнение основного заболевания

Диабетическая полинейропатия. диабетическая ангиопатия сосудов н/к.

Сопутствующие заболевания:

Хронический вирусный гепатит С. ХБП 2 ст. Хронический панкреатит ремиссия Дислипидемия. Рак предстательной железы cT3bN0M0. Лапароскопическая радикальная простатомия расширенная тазазная лимфаденэктомия 26.09.2023. Полиостеоартроз суставов кистей рук. Дорсопатия. Полисегментарный остеохондроз, спондилез позвоночника, множественные протрузии , грыжи м/ дисков в шейном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Кубитальный синдром с двух сторон, больше справа.

Дополнительные сведения о заболевании Состояние пациента при поступлении

Консультация специалистов

Консультация Невролога 21.06.24 - Дорсопатия. Полисегментарный остеохондроз, спондилез позвоночника. множественные протрузии , грыжи м/дисков в шейном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Кубитальный синдром с двух сторон, больше справа. Диабетическая полинейропатия сенсорная форма.
Консультация Эндокринолога от 21.06.24 - Сахарный диабет 1 тип. целевой уровень гликированного гемоглобина 7 % Диабетическая полинейропатия. Диабетическая ангиопатия сосудов н/к.

Результаты медицинского обследования

Лабораторные исследования:

- 1) 18.06.2024 B03.016.006 - **Общий (клинический) анализ мочи:** Билирубин (качественно) - Neg; Лейкоциты - Neg кл/мкл; Уробилиноген (качественно) - норма; Эритроциты (качественно) - отсутствует; Нитриты - Neg; Относительная плотность - 1.025 (Б/раз); Глюкоза - Neg ммоль/л; Белок - Neg г/л; Уробилиноген - 3.4 (ммоль/л); Кетоны (качественно) - Neg;
- 2) 18.06.2024 B03.016.004 - **Анализ крови биохимический общетерапевтический:** Мочевина - 5.6 (ммоль/л) (норма 3.2-7.3); Билирубин общий - 8.2 (мкмоль/л) (норма 1.7-21.0); АЛТ - 15.0 (ед/л) (норма 0.0-41.0); АСТ - 19.0 (ед/л) (норма 0.0-35.0); Белок общий - 71.0 (г/л) (норма 66.0-88.0); Глюкоза - 6.9 (ммоль/л) (норма 3.9-6.4); Креатинин - 70.0 (мкмоль/л) (норма 80.0-115.0);
- 3) 18.06.2024 B03.016.003 - **Общий (клинический) анализ крови развернутый:** Тромбоциты (PLT) - 222.0 (10E9/л) (норма 150.0-400.0); Средняя конц. гемоглобина (MCHC) - 348.0 (г/л) (норма 320.0-360.0); Индекс распр. эритроцитов (RDW-SD#) - 9.8 (фл) (норма 35.0-56.0); Средний объем тромбоцита (MPV) - 8.3 (фл) (норма 6.5-12.0); Лейкоциты (WBC) - 5.42 (10E9/л) (норма 4.0-10.0); Моноциты (MON#) - 0.46 (10E9/л) (норма 0.12-1.2); Эритроциты (RBC) - 4.9 (10E12/л) (норма 3.5-5.5); Процент больших тромбоцитов (LPCR) - 15.5 (%) (норма 11.0-45.0); Гемоглобин (HGB) - 153.0 (г/л) (норма 110.0-160.0); Индекс распр. тромбоцитов (PDW-CV) - 14.8 (%) (норма 10.0-17.9); Индекс распр. эритроцитов (RDW-CV) - 13.9 (%) (норма 11.0-16.0); Лимфоциты (LYMF#) - 2.0 (10E9/л) (норма 0.8-4.0); Среднее сод. гемоглобина (MCH) - 31.2 (пг) (норма 27.0-34.0); Моноциты (MON%) - 8.4 (%) (норма 3.0-12.0); Гранулоциты (GRA%) - 54.7 (%) (норма 43.0-76.0); Гематокрит (HCT) - 44.0 (%) (норма 37.0-54.0); Тромбоцит (PCT) - 0.183 (%) (норма 0.108-0.282); Лимфоциты (LYMF%) - 36.9 (%) (норма 20.0-40.0); Гранулоциты (GRA#) - 2.96 (10E9/л) (норма 1.2-6.8); Средний объем эритроцита (MCV) - 89.7 (фл) (норма 80.0-100.0);
- 4) 18.06.2024 A09.05.026 - **Исследование уровня холестерина в крови:** Холестерин общий - 6.1 (ммоль/л) (норма 0.0-5.2);
- 5) 18.06.2024 B03.005.006 - **Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза):** Протромбиновое время - 13.0 (сек); АЧТВ - 30.6 (сек); Фибриноген - 3.2 (г/л); МНО - 1.0 (Б/раз);
- 6) 22.06.2024 A26.06.082.002 - **Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови:** AT IgG к сифилису (Treponema pallidum) - не обнаружено (не обнаружено);

Инструментальные исследования:

- 1) 18.06.2024 7014145 Электрокардиография : Ритм синусовый. ЧСС= 79 уд./мин. Нормальное направление электрической оси сердца. Увеличение левого предсердия. Перегрузка правого предсердия. Не исключается гипертрофия миокарда левого желудочка. Диффузные изменения миокарда, более выраженные в области нижней стенки левого желудочка (исключить субэндокардиальное ишемическое повреждение миокарда этой зоны).
- 2) 18.06.2024 7005473 Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях : Ритм синусовый. ЧСС= 65 уд./мин. Нормальное направление электрической оси сердца. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Увеличение левого предсердия. Перегрузка правого предсердия. Вероятно, гипертрофия миокарда левого желудочка. Диффузные изменения миокарда, более выраженные в области нижней стенки левого желудочка.
По сравнению с ЭКГ от 17.06.2024 г. 17 ч. 33 мин.: урежение ЧСС с 79 до 65 уд./мин, уменьшилась нагрузка на левый желудочек.
- 3) 19.06.2024 7003908 Рентгенография кисти : Больше данных за обменно-дистрофический полиостеоартроз кистей.
- 4) 25.06.2024 7004435 Ультразвуковое исследование органов мошонки : радикальная простатэктомия
- 5) 25.06.2024 7005408 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости : Хронический бескаменный холецистит, перегиб шейки пузыря. Хронический панкреатит. Спленомегалия
- 6) 25.06.2024 7004542 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства : хронический бескаменный холецистит, перегиб шейки пузыря точки хронический панкреатит. Спленомегалия
- 7) 25.06.2024 7012818 Ультразвуковое исследование мягких тканей подвздошно-паховой области : Неспецифический паховый лимфаденит
- 8) 25.06.2024 7008428 Ультразвуковое исследование паховых лимфатических узлов : неспецифический паховый лимфаденит

Лекарственные назначения

натрия хлорид, магний сульфат, тиактовая кислота, актовегин, инсулин гларгин, инсулин новорапид, диклофенак, омегапризол

Состояние при выписке

Состояние пациента Удовлетворительное

Режим

Наблюдение у Терапевта, Эндокринолога, Онколога, Невролога, консультация Ревматолога, Нефролога.

Рекомендованное лечение

диета № 9, инсулин гларгин (туждео) по 10 ед н/н, инсулин аспарт (новорапид) по 10 ед 3 раза перед едой, аторвастатин 20 мг вечером контроль липидного профиля + аст алт через 3 месяца

Трудовые рекомендации

-

Прочие рекомендации

-

Врач

Конгуров Ихтиёржон Махаматжонович, Терапия

Автор: Конгуров Ихтиёржон Махаматжонович

Дата: 26.06.2024

